Find vejen frem
VIA University College

VIA University College



Neurodiversitet og pædagogik

Liv i Skolen
Nr. 3 · Oktober 2026 · 28. årgang

Tema:
Neurodiversitet og pædagogik

Udgiver:
VIA Efter- og videreuddannelse
Hedeager 2
8200 Arhus N
T: 87551900

Henvendelse:
liviskolen@via.dk

Redaktion:
Morten Stokholm Hansen

Ansvarshavende:
Torben Kirkegaard

Layout: Inge Lynggaard Hansen

Foto: Colourbox og Inge Lynggaard Hansen

Tryk: Stibo complete A/S

ISSN: 1398-2613

Ideer og bidrag til artikler, kontakt:
msh@via.dk

Kommentér dette nummer af Liv i Skolen på Facebook: **www.facebook.com/ViaPaedagogiskVidereuddannelse**

Liv i Skolen vil gerne gøres bekendt med gode eksempler fra praksis i forbindelse med temaerne, og vi vil gerne sende på flere kanaler.

Kontakt os omkring et tema, og vi vil vurdere, om det skal belyses i bladet, i en artikel på nettet eller eventuelt i en video på nettet.

Priser 2026

Årsabonnement	400 kr.*
2 abonnementer	600 kr.*
3 abonnementer	800 kr.*
Enkeltnumre 2025-2026	125 kr.*
Enkeltnumre før 2025	95 kr.*

*Priser er inkl. moms, ekskl. forsendelse
Køb af abonnement og enkeltnumre:
via.dk/efter-ogvidereuddannelse/paedagogik-laering/liv-i-skolen

Abonnementsperioden følger kalenderåret

Hent uddrag af artikler fra disse numre på www.liviskolen.dk:
3/2026 Neurodiversitet og pædagogik
2/2026 Fagligt løft i dansk
1/2026 Mere praksis i skolen – tak!
4/2025 Deltagelsesmuligheder for alle…

Hent digitale udgaver af artikler fra bl.a. disse numre på www.liviskolen.dk:
3/2025 Børnehaveklassen
2/2025 Legende læring i skolen
1/2025 Kunstig intelligens i skolen
4/2024 Specialpædagogik – tæt på skolens praksis
3/2024 Trivsel og mistrivsel i skolen
2/2024 Læreruddannelsen – tæt på praksis
1/2024 Frisættelsen af Folkeskolen
4/2023 Ukrainske børn i den danske skole
3/2023 Viden og værdier
2/2023 Filosofi med børn
1/2023 Det tværprofessionelle samarbejde
4/2022 Skolefravær
3/2022 Mellemformer i skolen

1193 - ilh - 10.26

Velkommen til dette nummer af Liv i Skolen om Neurodiversitet og pædagogik

Elever er ikke ens – og det har de aldrig været. I dag taler vi i stigende grad om neurodiversitet som en måde at forstå og anerkende, at vores hjerner fungerer forskelligt. Det udfordrer skolens vante rammer, fællesskaber og forestillinger om normalitet. Samtidig åbner det for nye pædagogiske muligheder og mere nuancerede blikke på læring og trivsel. Hvordan skaber vi en skole, der både kan rumme forskelle og sikre fælles retning? Og hvad kræver det af lærere, pædagoger og skolekultur, når forskellighed ikke ses som et problem, men som et vilkår og en berigelse?

Rigtig god læselyst.
Karina Engelund Mathiasen, fagredaktør og Morten Stokholm Hansen, redaktør

INDHOLD

06 Neurodiversitet eller neurodivergens?
To enslydende begreber – to vidt forskellige pædagogikker. Begreber former ikke blot vores sprog om børn. De former også de spørgsmål, vi stiller, de løsninger, vi vælger, og den pædagogik, vi praktiserer. Med afsæt i neurovidenskab og historien undersøger denne artikel, hvorfor forskellen mellem neurodiversitet og neurodivergens er langt mere end en sproglig nuance.
Af Trine Holck Grundahl, lektor

18 Lommer af nærvær – et fundament i pædagogisk praksis
Visuelle strukturer, hjælp til forudsigelighed og overblik er vigtige pædagogiske tiltag for elever med ADHD, men de virker sjældent uden et trygt relationelt fundament. Når de eksekutive funktioner er udfordrede, har eleven først og fremmest brug for en voksen, der viser forståelse, skaber ro, tryghed og følelsesmæssig regulering.
Af Mette Birk, pædagogisk psykologisk konsulent og Rebekka Brødsgaard Knudsen, praktikant

28 Neurodiversitet – om hvordan forskellighed bidrager til bæredygtige læringsmiljøer
Begrebet neurodiversitet tilbyder både fagprofessionelle, samt børn med bl.a. ADHD og autisme (og deres forældre) et andet blik på diagnoser. Artiklen omhandler både fordele og ulemper ved begrebets udbredelse, samt de paradokser der er forbundet hermed. Undervejs tages der ud gangspunkt i eksempler fra praksis og de betydninger, det kan få for børn, når blikket flyttes fra fejl og mangler til styrker og potentialer.
Af Kirstine Bang Kruse Kristensen, adjunkt

38 Crip Tid: Tiden er ikke ens for alle – om børns sansende oplevelser i og af tid i skolen
Tid er dybt indlejret i skolers hverdag og et centralt greb i skolernes organisering og i lærernes didaktiske planlægning. Tidens indlejring i skolers hverdagsliv medvirker til, at det kan være vanskeligt at forholde sig kritisk til tid, men det er ikke desto mindre vigtigt, da skolens børn er forskellige, og børn ikke oplever tid ens.
Af Anne-Lene Sand, lektor og ph.d., og Kasper Moes Drevsholt, lektor

46 Fra kompensation til deltagelse
Ser vi tilbage på de seneste årtier har verden åbnet sig op, vi rejser ud og oplever nye kulturer, andre kulturer er rejst ind, køn og seksualitet har fået flere facetter, familieformer findes i mange varianter. Vi er på mange måder blevet en mere mangfoldig folkegruppe. Til trods for dette ser vi blandt børn og unge et mere og mere snævert normalitetsbegreb, hvor det perfekte opleves som normalen.
Af Karina Engelund Mathiasen, lektor

56 Når fortællinger former børns muligheder for deltagelse
Neurodiversitet minder os om, at forskellighed ikke er en fejl, der skal rettes, men et grundvilkår i skolen. Netop derfor bliver de fortællinger, vi skaber om børn, afgørende for, om forskellighed mødes som et problem hos barnet eller som et fælles pædagogisk ansvar.
Af Julie Rytter Hoijer, specialvejleder

68 Følelser og affekt: følelser er ikke noget vi har, men noget vi skaber
Kan du se på et barns ansigt, at det er vredt? Eller høre på stemmen, at det er bange? De fleste af os tror det, men ny hjerneforskning tegner et andet billede. Følelser findes ikke som færdige mønstre i hjernen, klar til at blive aflæst i et ansigtsudtryk eller en handling. De bliver konstrueret i konteksten og af alt det, et barn har med sig af krop, sprog, kultur og relationer.
Af Anette Kirkegaard Aebeloe, adjunkt

80 Drop jagten på ro i klassen – skab tryghed først
Uro og manglende deltagelse i skolen skyldes ofte et overbelastet nervesystem snarere end mangel på vilje, hvilket kræver et skifte fra symptombehandling til fokus på neurologisk tryghed. Reel inklusion kræver derfor en radikal ændring af professionsforståelsen, hvor rammerne tilpasses, frem for at arbejdsro kræves gennem adfærdsstyring.
Af Anita Boelsmand, timelærer

90 Fra deltagelsesmuligheder til bidragsparathed
I diskussioner om neurodiversitet i skolen rettes opmærksomheden ofte mod, hvordan neurodivergente elever kan få bedre muligheder for at deltage i undervisningens fællesskaber. Denne artikel argumenterer for, at spørgsmålet om deltagelse ikke er tilstrækkeligt. Det centrale spørgsmål er snarere, om fællesskabet er bidragsparat. Og om det kan modtage og anerkende forskellige måder at være elev på som betydningsfulde bidrag.
Af Mads Rune Dahlstrøm, lektor



Neurodiversitet eller neurodivergens?

To enslydende begreber – to vidt forskellige pædagogikker



Trine Holck Grundahl er lektor og underviser i neuropsykologi og neuropædagogik på EVU i VIA University College

Begreber former ikke blot vores sprog om børn. De former også de spørgsmål, vi stiller, de løsninger, vi vælger, og den pædagogik, vi praktiserer. Med afsæt i neurovidenskab og historien undersøger denne artikel, hvorfor forskellen mellem neurodiversitet og neurodivergens er langt mere end en sproglig nuance.

Som underviser i neuropsykologi og neuropædagogik må jeg indrømme, at jeg i disse år med stigende undren betragter den måde, neurologiske begreber anvendes på i den pædagogiske debat. Hjernen er i stigende grad blevet den foretrukne forklaringsmodel, når børn har vanskeligt ved at trives, deltage eller leve op til skolens forventninger, og begreber som neurodiversitet, neurodivergens og neurotypisk anvendes ofte uden den faglige præcision, som både pædagogikken og neurovidenskaben kalder på.

Det bekymrer mig. Ikke fordi jeg ønsker mindre viden om hjernen - tværtimod. Problemet opstår, når neurologiske begreber på et usikkert videnskabeligt grundlag får karakter af et fagligt trumfkort, der bringer den pædagogiske nysgerrighed til ophør.

"X fra 2. klasse er urolig i klassen og smider med stole – men han er også neurodivergent."

Når et barns adfærd først forklares på den måde, oplever jeg ofte, at andre forklaringsmuligheder træder i baggrunden.

Spørgsmål om undervisningens organisering, klassens fællesskaber, relationernes kvalitet eller skolens egne forventninger mister let betydning, fordi forklaringen synes at være fundet – nemlig i forestillingen om, at årsagen til barnets vanskeligheder først og fremmest skal findes i barnets hjerne.

Men hvis vores forklaringer på børns vanskeligheder bygger på upræcise eller utilstrækkeligt underbyggede antagelser, risikerer de samtidig at lede vores pædagogiske handlinger i en uhensigtsmæssig retning.

Denne artikel undersøger derfor to af de mest anvendte og måske mest sammenblandede begreber i den pædagogiske debat: neurodiversitet og neurodivergens. Mit argument er, at de to begreber repræsenterer to grundlæggende forskellige måder at forstå børn på, og at valget mellem dem langt fra er sprogligt uskyldigt. Tværtimod former de næsten umærkeligt det menneskesyn, de pædagogiske analyser og de handlinger, som møder børn i folkeskolen.

Neurodiversitet og neurodivergens – en begrebsafklaring

Det er værd at bemærke, at både neurodiversitet og neurodivergens er begreber, der er opstået i sociale og identitetspolitiske bevægelser som emancipatoriske begreber – ikke som neurovidenskabelige klassifikationer. Begge begreber anvender ganske vist forstavelsen *neuro*, men de er ikke udviklet som naturvidenskabelige kategorier.

Begrebet neurodiversitet forbindes især med den australske sociolog Judy Singer, som i slutningen af 1990'erne formulerede begrebet som en kritik af den dominerende sygdomsforståelse af autisme og andre udviklingsmæssige forskelle (Singer, 1999). Med inspiration fra biodiversitetsbegrebet argumenterede Singer for, at neurologisk variation bør forstås som et naturligt vilkår ved den menneskelige art frem for som en afvigelse fra en biologisk norm. Neurodiversitet beskriver derfor ikke bestemte grupper af mennesker, men et perspektiv, hvor variation i menneskers måde at tænke, lære og sanse på betragtes som et grundlæggende vilkår ved menneskelig udvikling.

Begrebet neurodivergent opstod få år senere inden for den bredere neurodiversitetsbevægelse. Betegnelsen forbindes med den amerikanske aktivist Kassiane Asasumasu og blev udviklet som et identitetsskabende og politisk begreb, der skulle beskrive personer, hvis måde at tænke, sanse eller lære på opfattes som forskellig fra det, der betegnes som neurotypisk (Walker, 2021). Formålet var ikke at etablere en ny medicinsk kategori, men at skabe et sprog, hvor anderledeshed kunne forstås som legitim og ikke automatisk som sygdom eller mangel. I takt med begrebets udbredelse er *neurodivergent* imidlertid gradvist skiftet karakter. I dag anvendes det ofte som en samlebetegnelse for personer med blandt andet ADHD, autisme, dysleksi, Developmental Language Disorder (DLD) og en række andre diagnostiske kategorier. Dermed kommer begrebet let til at fungere som mere end en identitetsbetegnelse. Det bliver en beskrivelse af mennesker, hvis hjerner antages at adskille sig fra en neurotypisk hjerne.

Hvor neurodiversitet beskriver variation som et fælles menneskeligt grundvilkår, etablerer neurodivergens derfor let en sondring mellem den normale og den unormale hjerne. I den pædagogiske anvendelse kan der dermed opstå en implicit antagelse om, at årsagen til barnets vanskeligheder først og fremmest skal findes i en neurologisk afvigelse hos barnet. Men kan begreberne faktisk bære en neurovidenskabelig udredning?

Hvad viser neurovidenskaben egentlig?

Den moderne neurovidenskab har gennem de seneste årtier udviklet metoder, der gør det muligt at undersøge hjernens struktur og funktion med en detaljeringsgrad, som tidligere var utænkelig. MR-scanninger, PET-scanninger og andre billeddannende teknikker kan identificere en lang række neurologiske sygdomme, hvor hjernens struktur eller funktion er tydeligt forandret. Det gælder blandt andet hjernetumorer, hjerneblødninger, blodpropper i hjernen, multipel sklerose, Alzheimers sygdom og Huntingtons sygdom.

Men hvordan ser det ud med de diagnosekategorier, der fylder stadig mere i den pædagogiske debat, såsom ADHD, autisme og Developmental Language Disorder?

Hvis disse tilstande beskrives som neurodivergente, kunne man umiddelbart forvente, at neurovidenskaben har identificeret neurologiske markører, som adskiller disse hjerner fra andre. Netop dette spørgsmål har været genstand for intensiv forskning gennem de seneste årtier. Internationale forskningsprojekter har kortlagt genetiske variationer, analyseret hjernens netværk og sammenlignet hjernestruktur og hjernefunktion hos tusindvis af mennesker med og uden forskellige psykiatriske diagnosekategorier.

Det bemærkelsesværdige er imidlertid, at der fortsat ikke findes diagnostiske biomarkører, som med tilstrækkelig sikkerhed kan identificere ADHD, autisme eller andre neurodevelopmentale diagnosekategorier hos det enkelte barn. En omfattende systematisk gennemgang af forskningen i biomarkører fandt ingen, der opfyldte de nødvendige krav til tilstrækkelig sensitivitet og specificitet på tværs af uafhængige studier (Cortese et al., 2023). Diagnoserne stilles derfor fortsat på baggrund af kliniske vurderinger af blandt andet adfærd, funktionsniveau og udviklingshistorie. Hjerneskanninger, genetiske analyser og blodprøver kan endnu ikke anvendes som selvstændige diagnostiske redskaber til at identificere ADHD eller autisme hos det enkelte barn.

Paradoksalt nok synes udviklingen næsten at pege i den modsatte retning af det, mange havde forventet. Jo mere detaljeret neurovidenskaben undersøger hjernen, desto tydeligere bliver det, hvor vanskeligt det er at afgrænse psykiatriske diagnosekategorier som biologisk adskilte sygdomsenheder. Fremtrædende psykiatriske forskere har derfor peget på, at de nuværende diagnosekategorier kun i begrænset omfang afspejler klart adskilte biologiske tilstande, men snarere beskriver komplekse og delvist overlappende mønstre af udvikling, adfærd og funktion (Borsboom et al., 2019; Hyman, 2010; Insel et al., 2010). Hvis neurovidenskaben har leveret én robust erkendelse, er det derfor ikke forestillingen om den klart afgrænsede divergente hjerne, men snarere forståelsen af hjernen som plastisk, dynamisk og individuel. Hjernens struktur og funktion er ikke statiske, men udvikles og reorganiseres kontinuerligt gennem hele livet i et komplekst samspil mellem genetiske dispositioner, erfaringer, relationer og de miljøer, mennesket indgår i (Kolb & Gibb, 2011). Hjernens udvikling er en biologisk proces, hvor erfaringer over tid påvirker hjernens netværk gennem ændringer i synaptiske forbindelser. Hjernen er dermed ikke blot et organ, der passivt producerer adfærd på baggrund af nogle hjernestrukturer. Den er også et organ, der hele tiden tilpasser sig og udvikles i mødet med den verden, kroppen befinder sig i.

Neurovidenskaben tegner dermed et billede af hjernen, hvor en kompleks og ikke-reproducerbar kombination af genetik og miljø bidrager til udformningen af hjernens biologiske struktur og funktion og understøtter derved ideen om den neurodiverse hjerne.

Derimod findes der aktuelt ikke belæg for, at en bestemt udfordrende adfærd og en bestemt psykiatrisk diagnose nødvendigvis skyldes en afgrænset "fejl" i hjernen. I den betydning bliver begrebet *neurodivergent*, når det anvendes som en forklaring på et barns vanskeligheder, en påstand, som kræver større forsigtighed, end begrebet ofte får i den pædagogiske praksis.

Historiske perspektiver på biologiske forklaringer.
Den manglende evidens for diagnostiske biomarkører betyder naturligvis ikke, at børn ikke kan have betydelige vanskeligheder. Spørgsmålet er snarere, hvordan vi vælger at forstå og forklare disse vanskeligheder - og hvilke pædagogiske konsekvenser vores forklaringer får.

Historikeren Jennie Sejr Junghans viser i *Da børnesindet blev sygt* (2025), hvordan den danske børnepsykiatri opstod i tæt forbindelse med det moderne samfunds institutionalisering af barndommen. I 1935 åbnede Danmarks første børnepsykiatriske klinik på Rigshospitalet, og bogen viser, hvordan børnepsykiatrien udviklede sig i en periode, hvor stadig flere børn voksede op i institutioner – ikke mindst skolen – der stillede fælles krav til deres adfærd, deltagelse og udvikling (Junghans, 2025).

Børnepsykiatriens fremvækst må derfor forstås i sammenhæng med de institutionelle sammenhænge, hvor børns adfærd blev observeret og vurderet, og med samfundets behov for at forstå og håndtere de børn, der havde vanskeligt ved at passe ind i de eksisterende rammer.

Junghans viser interessant, hvordan forklaringerne på børns uro, impulsivitet og socialt udfordrende adfærd ændrer sig over tid i en pendulbevægelse mellem biologiske og miljømæssige forklaringsmodeller. I børnepsykiatriens begyndelse i starten af det 20. århundrede blev børns vanskeligheder ofte forklaret med biologiske egenskaber, som blev opfattet som medfødte og grundlæggende uforanderlige. Børn kunne eksempelvis beskrives som degenererede, konstitutionelt belastede eller psykopatiske.

Når børns vanskeligheder blev forstået som udtryk for barnets natur, blev forventningerne til barnets udviklingsmuligheder tilsvarende begrænsede. De historiske kilder viser, hvordan den pædagogiske praksis i højere grad kom til at handle om at kontrollere barnet, beskytte omgivelserne og adskille barnet fra fællesskabet end om at undersøge, hvordan barnet kunne udvikle sig gennem læring, relationer og deltagelse (Junghans, 2025).

Historien viser dermed, at biologiske forklaringer ikke blot har været neutrale beskrivelser af børn. De har også haft store konsekvenser for, hvad man mente, der kunne gøres med og for dem. Historien giver derfor grund til varsomhed over for forklaringsmodeller, der gør biologisk afvigelse til den primære forklaring på menneskers vanskeligheder, fordi sådanne forklaringer let kan påvirke vores forventninger til, hvad et menneske kan lære, udvikle og blive en del af.

Biologiske forklaringer kan bidrage til en reduktionistisk pædagogisk praksis, hvor mennesket først og fremmest betragtes gennem sin biologi – og ikke som et subjektivt og handlende menneske. Pædagogikken kan derved lettere bevæge sig i en retning, hvor ydre styring, kontrol, straf og adskillelse bliver konsekvensen. Historien om fx Godhavnsdrengene er en påmindelse om, hvor dehumaniserende samfundets behandling af børn kan blive, når børn, der ikke passer ind i de eksisterende rammer, mødes med psuedo-biologiske forklaringsmodeller med svigt, overgreb, vanrøgt og medicinske forsøg til følge (Rytter, 2011).

Mange vil nok mene, at så langt vil man aldrig gå i 2026. Men spørgsmålet er, om historien ikke netop bør få os til at undersøge, hvordan vores egne forklaringsmodeller former den pædagogiske praksis.

Den neurodivergente eller den neurodiverse folkeskole?
I dag diagnosticeres mere end hvert syvende barn eller ung i Danmark med mindst én psykisk lidelse, inden de fylder 18 år (Sundhedsstyrelsen, 2026). Samtidig er der sket en markant stigning i antallet af børn og unge, der diagnosticeres med blandt andet ADHD og autismespektrumforstyrrelser. Antallet af nye autismediagnoser blandt 0-17-årige steg eksempelvis fra cirka 2.400 i 2014 til cirka 4.900 i 2023. Psykiatriske diagnoser er dermed i stigende grad blevet en del af mange børns skoleliv – og dermed også af den pædagogiske praksis (Sundhedsstyrelsen, 2025).

Det er netop i lyset af denne udvikling, at forskellen mellem en neurodivergent og en neurodivers forklaringsmodel bliver et afgørende filosofisk og pædagogisk valg. Forestil dig to skoler, der møder det samme barn: X, som har svært ved at sidde stille, koncentrere sig og deltage i den undervisning, der foregår i klassen.

I den neurodivergente skole bliver spørgsmålet let: *Hvad er der galt med X?*

Vanskelighederne forstås som udtryk for en grundlæggende anderledes neurologi, og den naturlige løsning bliver derfor at udrede, diagnosticere og kompensere. Skolen tilbyder derefter særlige indsatser, redskaber eller placeringer til at kompensere for barnets divergens, - men samtidigt bliver barnet synligt markeret som et barn, der ikke kan deltage på samme måde som de andre. Skolen reproducerer derved anderledesheden i sin pædagogiske praksis. Det kan ske ved, at barnet placeres i en mellemform, får 1:1-bemanding eller sidder bag en skærm og kigger ind i væggen. Hvis disse tiltag ikke får barnet til at fungere inden for folkeskolens rammer, bliver næste skridt ofte, at barnet helt må forlade folkeskolen og begynde på en specialskole – i en total adskillelse fra det "normale" fællesskab.



I den neurodiverse skole bliver spørgsmålet et andet: *Hvordan kan vi som folkeskole skabe flere måder at deltage og lære på, så X får mulighed for at lykkes?*

En neurodivers skole vil skulle indrette sig efter en forståelse af, at nogle børn lærer bedre gennem bevægelse, at nogle bedre kan koncentrere sig, hvis undervisningen i højere grad foregår ude, er praktisk, legende og undersøgende, og at der derved skabes forskellige legitime måder at deltage i fællesskabet på, - uden man får et stempel af at være normal eller unormal. Et barns stærke særinteresse ses ikke nødvendigvis på med bekymring, men kan bruges som en indgang til læsning, matematik eller naturfag. Forskelligheden i mulighederne i den pædagogiske praksis skaber i sig selv et rum for diversitet – også for de børn, der godt kan lide at sidde stille på en stol i 45 minutter. De får øje på deres egen diverse position, og den pædagogiske organisering skaber dermed en hverdag, hvor børn ikke behøver at skelne mellem det normale og det unormale.

Spørgsmålet til jer læsere er: *Hvilken af de to skoler kan I bedst genkende fra jeres egen hverdag – og hvilken vil I helst arbejde i? (Se eventuelt testen i slutningen af artiklen.)*

De fleste lærere vil nok svare, at folkeskolen rummer en blanding af begge. Nogle vil måske hævde, at den neurodiverse skole er en idealistisk og urealistisk model, mens den neurodivergente model er en nødvendighed i den virkelighed, folkeskolen befinder sig i.

Men hvis vi tager Junghans' historiske analyse alvorligt, må vi overveje, om folkeskolen ikke selv er medskaber af den virkelighed, den fungerer i – og måske dermed også af uroen i klasserne og den stigende efterspørgsel på psykiatriske diagnoser. Når vi samtidig ved, at børn med de beskrevne diagnoser ikke kan identificeres som havende et entydigt neurologisk problem, må det være på tide, at folkeskolen ser på sig selv og påtager sig et voksent ansvar for at forandre praksis.

Her kan neurovidenskaben faktisk være en vigtig inspiration for pædagogikken. Den viser eksempelvis, at menneskers opmærksomhed ikke er en fast og uforanderlig egenskab, men formes af blandt andet mening, tryghed, forståelse, erfaringer og socialt samspil.

De to begreber repræsenterer **to grundlæggende forskellige måder** at forstå børn på.

En urolig krop er derfor ikke nødvendigvis et udtryk for en forkert hjerne, men kan være hjernens og kroppens naturlige reaktion på et miljø, som barnet ikke forstår, ikke føler sig trygt i eller ikke oplever som meningsfuldt.

Så hvis man i folkeskolen vil bruge neurovidenskaben som forklaringsmodel, er den videnskabelige konsekvens af dette valg derfor, at forklaringen på børns udfordrede adfærd også må rette blikket mod folkeskolens læringsmiljø – og ikke automatisk mod barnets hjerne. Hvor vanskelig denne konklusion end måtte være.

En folkeskole, der vil anvende neurovidenskaben som inspiration og argumentation, er derfor mere en neurodivers end en neurodivergent folkeskole. Den må være en skole, der tør og vil forandre organiseringen af hverdagens læringsmiljø. Ikke fordi alle børn skal have individuelle særordninger, men fordi skolen som udgangspunkt må kunne tilbyde flere måder at være deltagende, lærende og fælles på, - fordi den ved, - at hjerner er forskellige og derfor lærer forskelligt. Den må derfor som udgangspunkt være mere bevægelig, mere undersøgende og mere kreativ i sin organisering af læring.

Dette er ikke let, - det ved jeg - og dog – måske kræver det, som første spæde skridt, at lærere sammen med gode kollegaer stopper med at give barnet ansvaret for sin urolige adfærd, når der diskuteres på lærerværelset og til netværksmøder, - og i stedet stiller et andet og fundamentalt praksisændrende spørgsmål: *Hvad skal jeg/vi ændre, for at X kan få en meningsfuld og tryg skoledag?*

Og derefter (selvfølgelig) turde prøve noget nyt og ændre egen adfærd.



Testen er udviklet af Grundahl, T.H.(2026)

Referencer

Borsboom, D., Cramer, A. O. J., & Kalis, A. (2019). Brain disorders? Not really: Why network structures block reductionism in psychopathology research. *Behavioral and Brain Sciences, 42*, Article e2. https://doi.org/10.1017/S0140525X17002266

Cortese, S., Solmi, M., Michelini, G., Bellato, A., Blanner, C., Canozzi, A., Eudave, L., Farhat, L. C., Højlund, M., Köhler-Forsberg, O., Leffa, D. T., Rohde, C., de Pablo, G. S., Vita, G., Wesselhoeft, R., Martin, J., Baumeister, S., Bozhilova, N. S., Carlisi, C. O., Leno, V. C., Floris, D. L., Holz, N. E., Kraaijenvanger, E. J., Sacu, S., Vainieri, I., Ostuzzi, G., Barbui, C., & Correll, C. U. (2023). Candidate diagnostic biomarkers for neurodevelopmental disorders in children and adolescents: A systematic review. *World Psychiatry, 22*(1), 129–149. https://doi.org/10.1002/wps.21037

Hyman, S. E. (2010). The diagnosis of mental disorders: The problem of reification. *Annual Review of Clinical Psychology, 6*, 155–179. https://doi.org/10.1146/annurev.clinpsy.3.022806.091532

Insel, T. R., Cuthbert, B. N., Garvey, M. A., Heinssen, R. K., Pine, D. S., Quinn, K. J., Sanislow, C. A., & Wang, P. S. (2010). Research domain criteria (RDoC): Toward a new classification framework for research on mental disorders. *American Journal of Psychiatry, 167*(7), 748–751. https://doi.org/10.1176/appi.ajp.2010.09091379

Junghans, J. S. (2025). *Da børnesindet blev sygt*. Aarhus Universitetsforlag.

Kolb, B., & Gibb, R. (2011). Brain plasticity and behaviour in the developing brain. *Journal of the Canadian Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 20*(4), 265–276.

Rytter, M. (2011). *Godhavnsrapporten: En undersøgelse af klager over overgreb og medicinske forsøg på børnehjem 1945–1976*. Syddansk Universitetsforlag.

Singer, J. (1999). *Why can't you be normal for once in your life? From a "problem with no name" to the emergence of a new category of difference* [Doctoral dissertation, University of Technology Sydney].

Sundhedsstyrelsen. (2026). *Psykiske lidelser hos børn og unge*. Sundhedsstyrelsen.

Walker, N. (2021). *Neuroqueer heresies: Notes on the neurodiversity paradigm, autistic empowerment, and postnormal possibilities*. Autonomous Press.